

■ 脳卒中リハ／エビデンスの質

脳卒中リハのSR140本を評価、高品質はわずか2本

AMSTAR 2で92.9%が「重大な欠陥あり」 網羅的な検索を行ったのは4.3%

脳卒中リハの治療効果をまとめたシステマティックレビュー(SR)は、どこまで信頼できるのか。2021年1月～2023年9月に出た、RCTのメタ解析を含むSR 140本を、16項目のツールAMSTAR 2で評価した横断研究がPM R誌に出た。MEDLINE・EMBASE・PsycINFO・Cochrane Database of Systematic Reviewsを検索している。

全体の質が「高」とされたのは2本(1.4%)だけだった。「中」2本(1.4%)、「低」6本(4.3%)、「重大な欠陥あり(critically low)」は130本(92.9%)に上る。項目別では、網羅的な文献検索を行っていたSRは4.3%、除外した研究の一覧と理由を示していたのは12.9%、採用研究を十分に記述していたのは10.7%、元の研究の資金

源を報告していたのは7.9%だった。

質が比較的高かったのは、Cochrane SR、米国・欧州の責任著者、有害事象を報告したSRなど。著者は「質は不十分」と結論する。ただしAMSTAR 2は報告の欠陥を厳しく拾うツールで、結論の誤りを意味しない。SRを引く時は、検索の網羅性と除外研究の扱



結論の前に、方法の記載を見る

いを先に確かめたい。

出典 **PM R** ↗

数字で見る

140本

評価したSRの数

1.4%

全体の質が高だった割合

92.9%

重大な欠陥ありの割合

■ 通所介護／ADL

通所介護にPT・OTがいると、24か月のADL低下が小さい

TOUCHプログラムに参加し、通所介護を24か月以上続けた65歳以上1,908人を、PT・OT配置のある施設とない施設で傾向スコアマッチ(954人ずつ)し、運動FIM(mFIM)を開始時から6・12・18・24か月で追った。両群とも24か月で有意に低下したが、低下の始まりは対照群のほうが早かった。

24か月時点でPT・OT配置群のmFIMと移乗の低下は有意に小さく(P<



05)、群間差は最小可検変化量(MDC)を超えた。後ろ向きの観察研究で、未測定の交絡は残りうる。「止める」でなく「遅らせる」と読みたい。

出典 **JAMDA** ↗

■ 心臓リハ／利用促進

心臓リハの利用促進策、47RCTで開始率RR1.19・完遂率RR1.22

効果が確立し、ガイドラインで推奨されながら参加率の低い心臓リハ。その利用を増やす介入を、心筋梗塞・狭心症・血行再建後・心不全の成人を対象とするRCT 47件・計1万803人で統合した。教育・自己管理支援・動機づけ面接、在宅やデジタルなどの提供方法、案内状やメッセージ、ピアサポートが主な介入だった。

開始はRR 1.19(95%CI 1.11～1.29、27試験、確



実性は低)、継続はSMD 0.32(0.15～0.49、確実性は中)、完遂はRR 1.22(1.10～1.35、確実性は中)。開始率の確実性が低い点に注意。患者側と制度側を組み合わせる設計が勧められる。

出典 **Heart Lung Circ** ↗

短 信

〈サルコペニア〉多疾患併存者のサルコペニアGL

EFIMが37推奨(強30・弱7)を採択。握力か椅子立ち上がりを入力に、多要素運動と栄養を推奨 出典 [Eur J Intern Med](#) ↗

〈心リハ〉歩行ガイド心リハの手引書を公開

日本心臓リハ学会が全87頁で公開。CPXが使えない高齢・フレイル患者に歩行能力を指標に運動療法(報道) 出典 [PT-OT-ST.NET](#) ↗

〈フレイル〉2分間歩行が高いと認知障害が少ない

プレフレイル・フレイル4,477人の横断研究。歩行持久力の最高四分位でオッズ比0.15。因果は不明 出典 [GeroScience](#) ↗

〈心リハ〉AMI後の心リハ受療で2年死亡が低い

韓国9.3万人の請求データ。教育+4回以上でHR0.257。受療は14.5%で、交絡の影響が大きい観察研究 出典 [Yonsei Med J](#) ↗

〈脳損傷〉後天性脳損傷の入院リハ、歩行が改善

50人の後ろ向き研究。FAS3～5が24%から46%へ。対照群がなく、因果は言えない 出典 [Rev Assoc Med Bras](#) ↗

〈脳卒中〉ミラー療法とFES自転車、下肢が改善

重急性期45人のRCT(各群15)。両法とも対照よりFMA-LEが改善し、両法間に差はなし 出典 [Top Stroke Rehabil](#) ↗

〈脳卒中〉睡眠時間とリハ後の自立度の関連

入院29人を10日追跡。関連は入院時の自立度で異なる。著者は仮説生成の段階と明記 出典 [Neurol Sci](#) ↗

〈失語〉健側のbrain ageが失語重症度と関連

慢性期の左半球脳卒中188人。右半球の脳年齢が重症度を追加で7%説明(報道、原著J Neurosci) 出典 [Medscape](#) ↗